



MANGELERNÄHRUNG

CE 02/ UE 03
Die Selbstpflege unterstützen - Ernährung

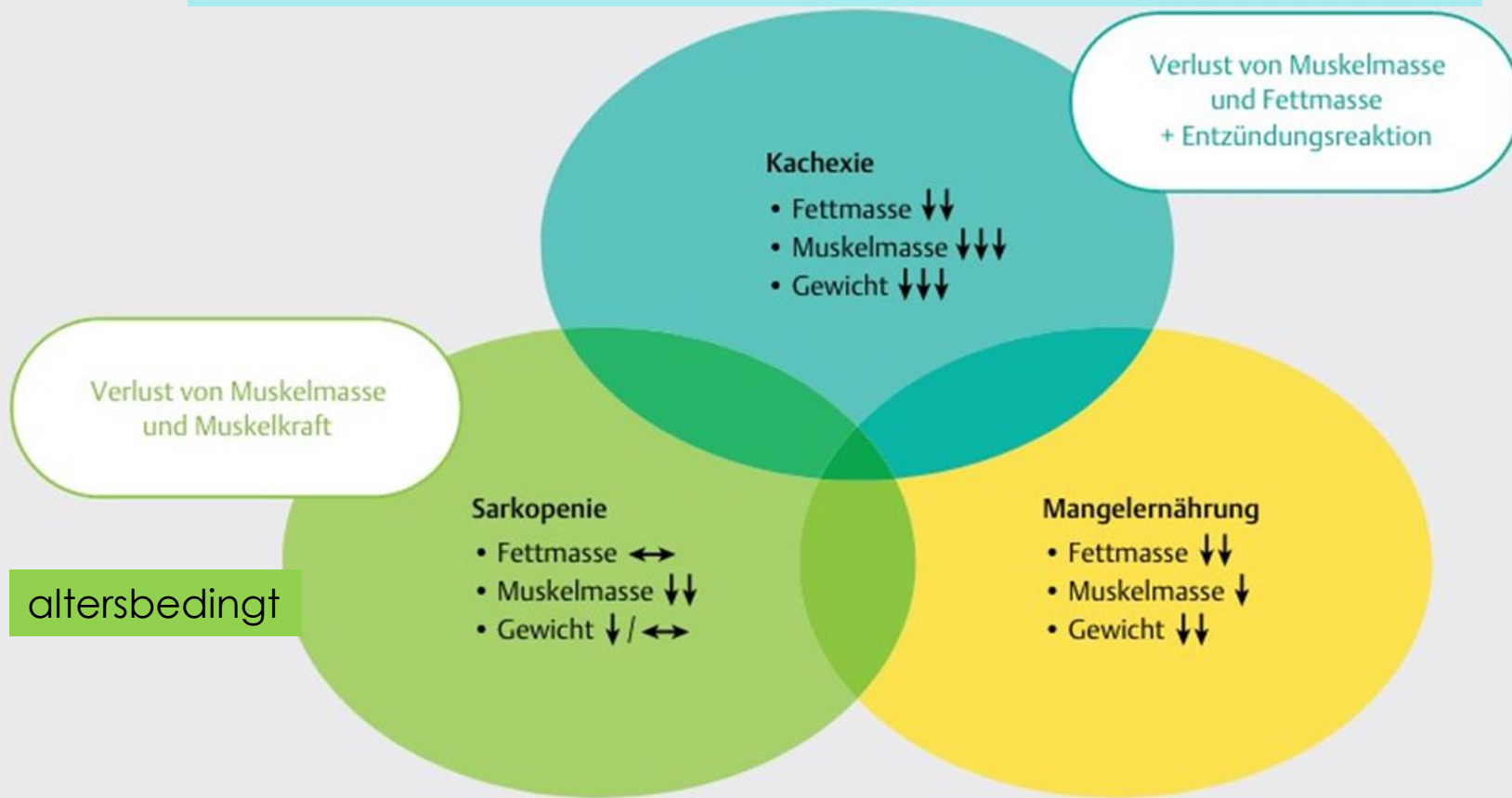


Was verbinden Sie mit
dem Begriff
„Mangelernährung“?

Definition von Mangelernährung

- Zustand, der entsteht, wenn über einen längeren Zeitraum hinweg nicht ausreichend Energie und lebenswichtige Nährstoffe aufgenommen werden, um den Bedarf des Körpers zu decken
- Dies führt zu negativen Auswirkungen auf den Ernährungs- und Gesundheitszustand sowie auf die physiologischen Funktionen
- Fachbegriff: **Malnutrition**

oft als Folge schwerer Krankheiten wie Tumor oder Herzinsuffizienz



Symptome

- Erschöpfung
- Mattigkeit
- Energiemangel
- Apathie
- Schwäche
- Abwehrschwäche
- Desorientierung
- Blasse Hautfarbe

- Hautfalten
 - ⇒ An Armen, Bauch und Gesäß
- Hervorstehende Knochen
 - ⇒ Im Gesicht, an der Wirbelsäule und an den Rippen
- Verlust von Unterhautfettgewebe mit eingefallenen Augen
- Trockene, schuppige Haut
- Mundrisse oder wund Stellen

Differenzierungen

Qualitative Mangelernährung	Quantitative Mangelernährung
Unterversorgung bestehend (= zu wenige <u>Vitamine</u> , <u>Mineralstoffe</u> , <u>Proteine</u> , etc.)	zu wenig Nahrung aufgenommen werden (= zu wenig <u>Kalorien</u>)

Globale Mangelernährung: Es fehlt an beidem.

Risikofaktoren und Ursachen

- **Nichtessen können**

- z.B. durch Übelkeit, Erbrechen, Erkrankungen im Mundraum, kognitive Einschränkungen (Demenz), Sehstörung, Beeinträchtigung der Mobilität der Arme + Hände (z.B. Lähmungen, Tremor)

- **Nichtessen wollen**

- z.B. durch soziale Isolation, unpassende Zeiten, Essen schmeckt nicht, psychische Erkrankungen (z.B. Anorexia nervosa)

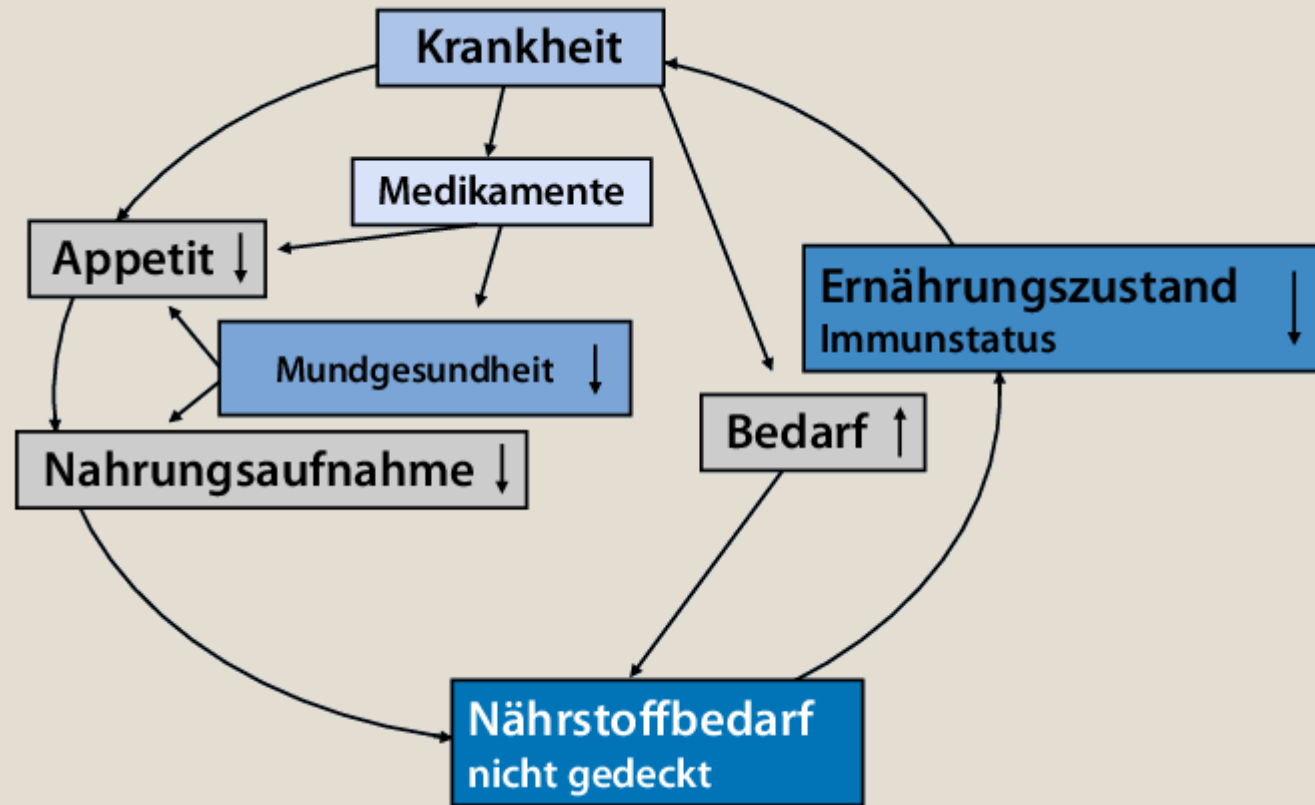
- **Erkrankungen**

- z.B. Gastritis, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, COPD, Demenz, Tumore

- **Medikamente**

- z.B. Polypharmazie führt zu Inappetenz (Appetitlosigkeit), Benzodiazepine, Digitalispräparate

Teufelskreis der Mangelernährung



Entstehung von Komplikationen, z.B.:

- Muskelschwäche
- Sturzrisiko
- Anfälligkeit für Infektionen
- Höheres Risiko Druckgeschwüre
- Probleme beim Denken + Verstehen
- Einsamkeit
- Langsame Wundheilung
- Schwierigkeiten bei der Genesung

Erfassung des Risikos

1. Berechnung Body-Mass-Index (BMI)

$$\text{BMI} = \frac{\text{Körpergewicht in Kilogramm}}{\left(\text{Körpergröße in Meter}\right)^2}$$

Beim Wiegen beachten:

- Morgens nach dem Toilettengang
+ vor dem Essen
- Leicht bekleidet
- Gleiche Waage benutzen

2. Betrachtung des Gewichtsverlustes (unbeabsichtigt/ beabsichtigt)

- Verlust von 5% des Körpergewichts über 6 Monate gilt als auffällig

Bewertung BMI

Kategorie	BMI	Körpergewicht
starkes Untergewicht	$\leq 16,0$	Untergewicht Dystrophie
mäßiges Untergewicht	16,0–17,0	
leichtes Untergewicht	17,0–18,5	
Normalgewicht	18,5–25,0	Normalgewicht
Präadipositas	25,0–30,0	Übergewicht
Adipositas Grad I	30,0–35,0	Adipositas
Adipositas Grad II	35,0–40,0	
Adipositas Grad III	$\geq 40,0$	

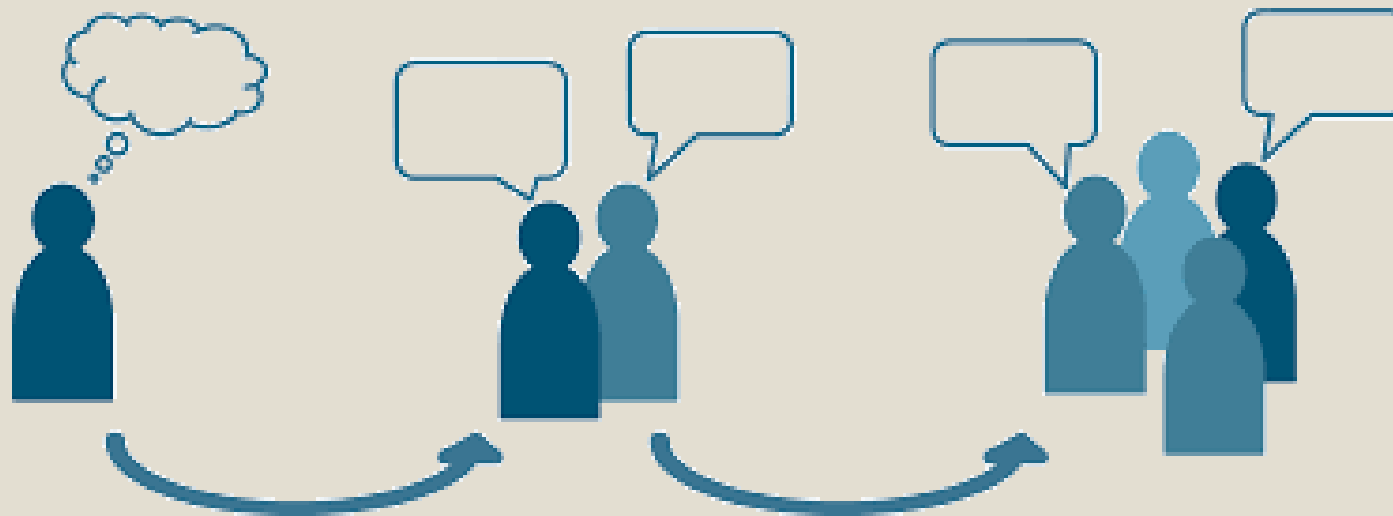
Bewertung BMI ab 64 Jahren



- muss im Alter neu bewertet werden, da der ideale BMI im höheren Alter ansteigt und ein etwas höherer BMI nicht zwangsläufig schlecht ist
- BMI zwischen 25 und 30 oft als gesundheitsförderlich angesehen

Aufträge

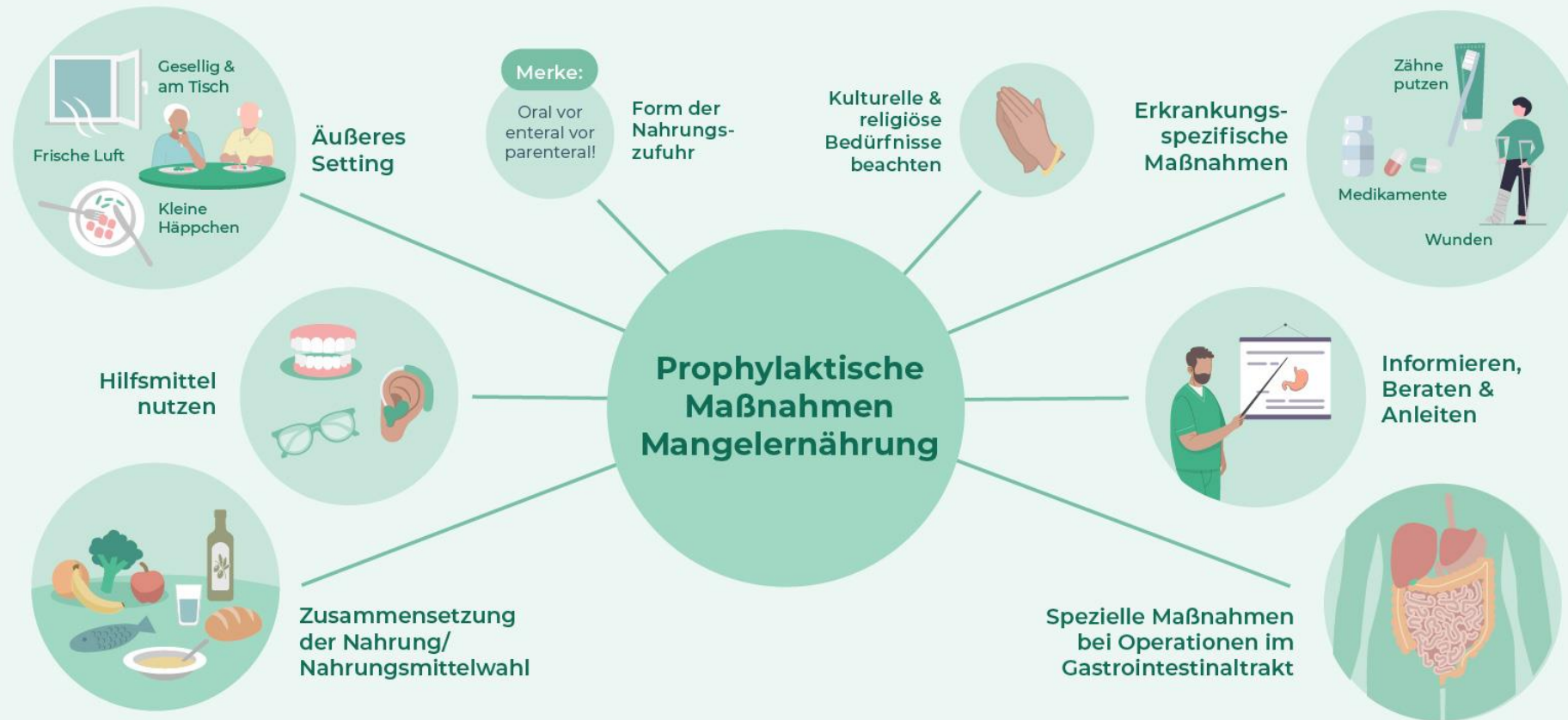
Datei ILIAS „AA Mangelernährung“



Ursachen

- Stationäre LZP
- Ambulante Pflege
- Krankenhaus

Prophylaktische Maßnahmen Mangelernährung



Die Pflegefachkraft erfasst bei allen Pflegeempfänger/innen zu Beginn des pflegerischen Auftrags im Rahmen der Pflegeanamnese, bei akuten Veränderungen und in individuell festzulegenden Abständen Anzeichen für eine drohende oder bestehende Mangelernährung (**Screening**). Sind entsprechende Anzeichen vorhanden, führt sie eine tiefergehende Einschätzung der Ernährungssituation und der sie beeinflussenden Faktoren durch (vertieftes **Assessment**).

Screening =

schneller, standardisierter Prozess, der dazu dient, Risiken zu identifizieren

Assessment =

umfassendere, detailliertere Untersuchung, die darauf abzielt, die Art und das Ausmaß eines Problems genauer zu bestimmen

Assessmentinstrumente

- Nutritional Risk Score (NRS)
 - Z. B. für Krankenhäuser
- Mini Nutritional Assessment (MNA) oder Mini Nutritional Assessment short form (MNA-SF)
 - Z. B. für geriatrische Einrichtungen
- Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)
 - Z. B. für die ambulante Versorgung
- Pflegerische Erfassung von Mangelernährung und Ursachen (PEMU)
 - Z. B. als detaillierteres Assessment bei auffälligem Screening-Ergebnis

Auftrag

- Lesen Sie das Fallbeispiel “Herr Wasilewski”.
- Wenden Sie das Instrument „Nutritional Risk Screening“ an.
- Planen Sie insgesamt **vier** Pflegemaßnahmen für Herrn Wasilewski, um seine Ernährungssituation zu verbessern.

Abschluss

Was nehmen Sie für Ihren Praxiseinsatz mit?